TD2 Outils de recueil et évaluation

Support de travail établi à partir des documents transmis. Le rattachement Moodle a été vérifié sur la liste des ressources ; les fichiers Moodle non récupérés et les commentaires audio ne sont pas déclarés intégralement contrôlés.

Cours et application

Choisir selon la question

Le score répond à une question précise et ne remplace pas l'entretien ou l'examen clinique. Vérifier que l'outil convient à la personne et suivre ses consignes de cotation. Ne pas additionner les scores de plusieurs échelles.

Douleur

Privilégier l'auto-évaluation si la personne comprend et peut répondre : EN, EVA ou EVS. Si elle ne peut pas s'auto-évaluer de façon fiable, choisir une échelle comportementale adaptée au contexte ; Doloplus concerne notamment la personne âgée présentant des troubles de communication.

Peau et nutrition

Braden repère un risque d'escarre : un score plus bas traduit un risque plus important. Le MNA dépiste un risque nutritionnel chez la personne âgée. Un dépistage positif conduit à approfondir l'évaluation ; il ne suffit pas, seul, à établir le diagnostic de dénutrition.

Autonomie et déplacements

AGGIR permet un classement en GIR, de 1 à 6, dans le cadre prévu. Tinetti explore équilibre et marche. Distinguer besoin d'aide pour un acte et capacité à décider : une personne dépendante pour la toilette peut conserver ses choix.

Après le score

Relier le résultat aux observations, aux ressources et aux risques. Prévoir une prévention individualisée puis réévaluer dans des conditions comparables. Transmettre le nom de l'échelle et le contexte, pas uniquement un nombre.

Documents Moodle

Le dossier contient des grilles et des productions étudiantes sur les six groupes d'outils. Le présent mémo reprend le document transmis ; il ne remplace pas les formulaires originaux de cotation.

Comparer les six familles d’outils du TD

Braden concerne le risque d’escarre : perception sensorielle, humidité, activité, mobilité, nutrition et friction ou cisaillement. Le score du document va de 6 à 23 et un score bas traduit un risque plus élevé. La prévention doit tenir compte des risques réellement retrouvés, et non du seul nombre.

EVA, EN et EVS recueillent l’évaluation de la personne. L’EN utilise une cotation numérique, l’EVA un repérage sur une réglette et l’EVS des qualificatifs. Vérifier la compréhension de la consigne et préciser le contexte, par exemple repos ou mobilisation, pour comparer l’évolution.

Doloplus comporte dix items répartis en dimensions somatique, psychomotrice et psychosociale, avec un score total de 0 à 30. Le seuil mentionné dans le document aide au repérage ; l’outil doit être utilisé dans son indication et selon ses consignes, sans transformer chaque comportement en preuve certaine de douleur.

AGGIR organise un classement en GIR, de la dépendance la plus importante en GIR 1 à l’autonomie la plus importante en GIR 6 dans ce cadre. MNA concerne le dépistage nutritionnel. Tinetti explore équilibre et marche. Ils ne répondent donc pas à la même question et leurs nombres ne sont pas comparables entre eux.

Passer du résultat à une action individualisée

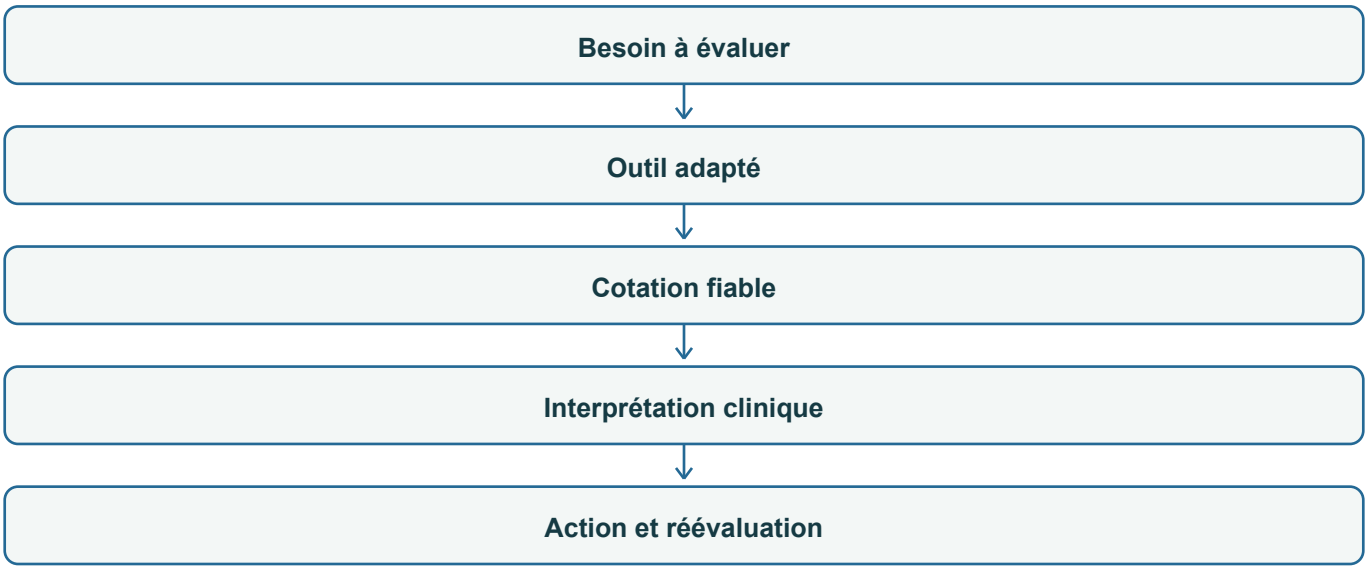
Avant la cotation, préciser l’objectif et réunir les conditions nécessaires : compréhension, observation suffisante, matériel et compétences pour l’outil. Ne pas inventer une réponse lorsque l’information manque. Suivre la manière prévue par la grille pour gérer une situation non cotable.

Après la cotation, expliquer ce que le résultat signifie dans cette situation. Un risque d’escarre peut conduire à adapter installation, mobilisation, gestion de l’humidité et apports. Un risque nutritionnel conduit à approfondir poids, prises, difficultés et causes, avec les professionnels concernés.

Exemple : une personne âgée ne parvient pas à utiliser une EN. Rechercher d’abord si une adaptation de la communication permet une auto-évaluation fiable. Si ce n’est pas possible, choisir une hétéro-évaluation adaptée. La difficulté à parler ne doit pas être assimilée automatiquement à l’impossibilité de comprendre.

Tracer le nom de l’outil, la date, les conditions, le score et les actions utiles. Réévaluer avec une méthode comparable et transmettre les changements. Les productions étudiantes présentes dans le dossier Moodle sont des supports de travail ; elles ne remplacent pas les formulaires officiels ni leurs consignes.

Schéma et vérification des acquis



Questions et réponses

Escarre : quel outil du TD ? Braden.

Nutrition : quel outil du TD ? MNA, puis évaluation clinique si besoin.

Un score suffit-il à décider ? Non : il doit être contextualisé.

Sources et portée

UE A1 TD OUTIL D'EVALUATION.docx

Ressource Moodle correspondante